DATO DE ATENCIÓN URGENCIA (DAU)

ESTABLECIMIENTO :	HOSPITAL SAN CARLOS	NºDAU :	3323343
CALIDAD :	Original	FECHA :	04/10/2023 14:09
AREA :	U.E. Adulto	BOX :	Cama 1
HC :	2003229761	CTA. CTE. :	0

DATOS CONSULTANTE:

Nombre : RODOLFO ARMANDO SOTO VALDES **RUN** : 3.761.666-4 **CP** : 372410
Previsión : FONASA B **F.Nac** : 10/12/1935 **Género** : Masculino **Edad** : 87 Años 9 Meses 24 Días
Dirección : BUCALEMU **Comuna** : NIQUEN **Teléfono** : 997126299

DATOS INGRESO:

Procedencia : SAN GREGORIO (CESFAM) **Mot. Consulta** : MORBILIDAD COMUN
Lug. Ocurrencia : NO_ESPECIFICADO **Med. Llegada** : AMBULANCIA SAPU CESFAM

SELECTOR DEMANDA: 1° llamado: 04/10/2023 14:18:45;

Profesional : MATÍAS POLANCO ORELLANA **Hra. Llamada** : 04/10/2023 14:18 **Hora Atención** : 04/10/2023 14:23
T° Axilar : 0 **T° Rectal** : **Presión** : **Pulso** : 82 **Frec. Resp.** : 0
Saturometría : 95 **HGT** : **Peso** : **Glasgow** : **Clasificación** : C2
Motivo de consulta: : IC POR ICC.
AM HTA - DM NO IR - HIPOTIROIDISMO - CADÍOPATA - ALERGIAS NO.

CONTROL SIGNOS VITALES:

Fecha	Pulso	Presión	T° Axilar	T° Rectal	FR	Sat.	HGT	Profesional
04/10/2023 14:24	65	77/56				95	102	MATÍAS POLANCO ORELLANA
04/10/2023 14:28	81	98/58	36.1		15	95	106	Lorena Hernandez Fuentes
04/10/2023 16:23	77	76/59	36.4		20	95		Lorena Hernandez Fuentes
04/10/2023 17:29		100/58						Francisco Parada Riquelme

ACCIDENTE, ALCOHOLEMIA Y/O TOXICOLOGIA:

INFORME LESIONES : NO **INFORME ALCOHOLEMIA:** : NO

ANAMNESIS:

Fecha	Anamnesis	Profesional
04/10/2023 14:34	Motivo de consulta: Derivado desde APS por compromiso del estado general. Paciente masculino de 87 años, con antecedentes de IAM, ICC con FEVI reducida, hipotiroidismo, DM2 y FA crónica. Consulta por cuadro de 3 días con dolor abdominal, náuseas, vómitos y disminución de ingesta. En APS hipotenso, por lo que derivan a urgencia. Ingresa con deshidratación, TA 76/59 mmHg y somnolencia. Mejoría con solución salina endovenosa (1000cc). Niega dolor torácico típico o disnea. Antecedentes: IAM previo, ICC FEVI reducida, hipotiroidismo, DM2, FA crónica anticoagulada. Tratamiento habitual: Furosemida, omeprazol, levotiroxina, tramadol, paracetamol, metformina, sacubitrilo/valsartan, dapagliflozina, rivaroxaban, carvedilol, espironolactona, alopurinol, pregabalina.	Felix Antonio Sanhueza Luna
04/10/2023 17:01	Exámenes: - Hemograma: Leucocitos 5.9, Hb 14.9, Plaquetas 227. - Perfil bioquímico: Gluc 106, BUN 31, Cr 1.6, Na 139, K 3.4, Cl 94. - Perfil cardíaco: CKMB 17, Troponina 39.1, Dimero D 500 Rx torax no congestiva ECG FA con RV adecuada	Felix Antonio Sanhueza Luna

EXAMEN FÍSICO :

Fecha	Examen Físico	Profesional

DIAGNÓSTICOS: **Condición de ingreso:** Conciente

Fecha	Hipótesis diagnóstica	Profesional
04/10/2023 14:34	1. Hipoaliemntación e hidratación inadecuada. 2. Tendencia a la hipotensión, recuperada. Probable sobremedicación relativa de hipotensores crónicos. 3. Lesión renal aguda en seguimiento.	Felix Antonio Sanhueza Luna
04/10/2023 18:35	N17.9 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA, NO ESPECIFICADA	Felix Antonio Sanhueza Luna

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y/O TERAPÉUTICOS (TRATAMIENTO EN BOX):

Fecha	Procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos	Profesional	Estado	Responsable
04/10/2023 14:35	METOCLOPRAMIDA 10 MG EV + PARACETAMOL 1 G EV	Felix Antonio Sanhueza Luna	Ejecutado el 04/10/2023 14:49	Paz Valentina Del Solar Reveco
04/10/2023 14:35	EXS DE LAB	Felix Antonio Sanhueza Luna	Ejecutado el 04/10/2023 14:49	Paz Valentina Del Solar Reveco
04/10/2023 14:37	SS 250	Felix Antonio Sanhueza Luna	Ejecutado el 04/10/2023 14:49	Paz Valentina Del Solar Reveco
04/10/2023 14:37	RX TORAX	Felix Antonio Sanhueza Luna	Ejecutado el 04/10/2023 14:49	Paz Valentina Del Solar Reveco
04/10/2023 16:53	bolo 250	Felix Antonio Sanhueza Luna	Ejecutado el 04/10/2023 16:54	Francisco Parada Riquelme

EXAMENES:

Fecha	Examen	Profesional
04/10/2023 14:35	HEMOGRAMA ; GLICEMIA ; UREMIA ; CREATININEMIA ; PERFIL HEPATICO ; PERFIL BIOQUIMICO ; CK TOTAL ; CK-MB ; E.L.P. ; PCR ; TTPK ; INR ; LDH ; TROPONINA I ; OTROS ;	Felix Antonio Sanhueza Luna
04/10/2023 18:35	HEMOGRAMA ; GLICEMIA ; UREMIA ; CREATININEMIA ; PERFIL BIOQUIMICO ; E.L.P. ; PCR ; TTPK ; INR ;	Felix Antonio Sanhueza Luna
04/10/2023 14:37	RX T?RAX FRONTAL Y LATERAL	Felix Antonio Sanhueza Luna

INDICACIONES ALTA:

Fecha	Indicación	Profesional
04/10/2023 14:34	- Hospitalización domiciliaria - Regimen hiposódio - Controles de signos vitales diarios - Control de exámenes en 48 hrs para evaluar evolución renal. - Ajuste de tratamiento crónico: - Suspender furosemida transitoriamente - Levotiroxina 50mcg/día - Suspender tramadol - Paracetamol 500mg c/8hrs - Reducir dosis de sacubitrilo/valsartan (entresto) a 50mg/día 1/2 comp al dia - Dapagliflozina (Forxiga) 10mg/día	Felix Antonio Sanhueza Luna

	- Rivaroxaban (Xarelto) 15mg/día - Carvedilol 6.25mg/día - Alopurinol 100mg/día - Suspender pregabalina - Consultar en urgencia según evolución	
04/10/2023 18:26	.	Felix Antonio Sanhueza Luna

RECETAS:

Fecha	Prescripción	Profesional

OBSERVACIONES:

Fecha	Indicación	Profesional
04/10/2023 14:30	Se recibe paciente en Sala de Observación desde triage, derivado Cesfam de San Gregorio, por mareos, cansancio y debilidad en extremidades inferiores, se monitoriza y se controla signos vitales completos, donde destaca hipotensión moderada, resto en parámetros normales.	Lorena Hernandez Fuentes
04/10/2023 15:54	Se recibe en sala de observación usuario masculino, adulto mayor, de 87 años, autovalente, con antecedentes de DM NIR, HTA, arritmia cardiaca, IAM hace 15 años, hipotiroidismo y perdida visual derecha asociada a glaucoma. Derivado desde San Gregorio con IC por ICC, familia refiere cuadro de mareos + disnea y CEG de 5 días de evolución. Al CSV ingresa hipotenso, resto de hemodinamia estable. Al ex físico Glasgow 15 pts, tranquilo, cooperador, normocráneo, destaca lesión ocular derecha por glaucoma, mucosas hidratadas, yugulares planas, tórax simétrico, dolor de tope inspiratorio, ABDI, extremidades sin edema. Se instala VVP#18 en ESI, se toman exs, se adm tto SIM.	Francisco Parada Riquelme

GES : No **PERTINENCIA** : Si **DESTINO** : Hospital APS

ADVERTENCIA
ESTE ES UN DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO Y SÓLO UNA PRIMERA ATENCIÓN. DEBE CONSULTAR A SU CENTRO DE SALUD O MÉDICO TRATANTE DENTRO DE LAS 12-24 HORAS SIGUIENTES. SI SUS SÍNTOMAS EMPEORAN, CONSULTE NUEVAMENTE A LA BREVEDAD. ES SU RESPONSABILIDAD SEGUIR ESTAS INDICACIONES.

LLAME A SALUD RESPONDE
600•360•7777
PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS DUDAS LAS 24 HORAS, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

Felix Antonio Sanhueza Luna
14.542.245-0